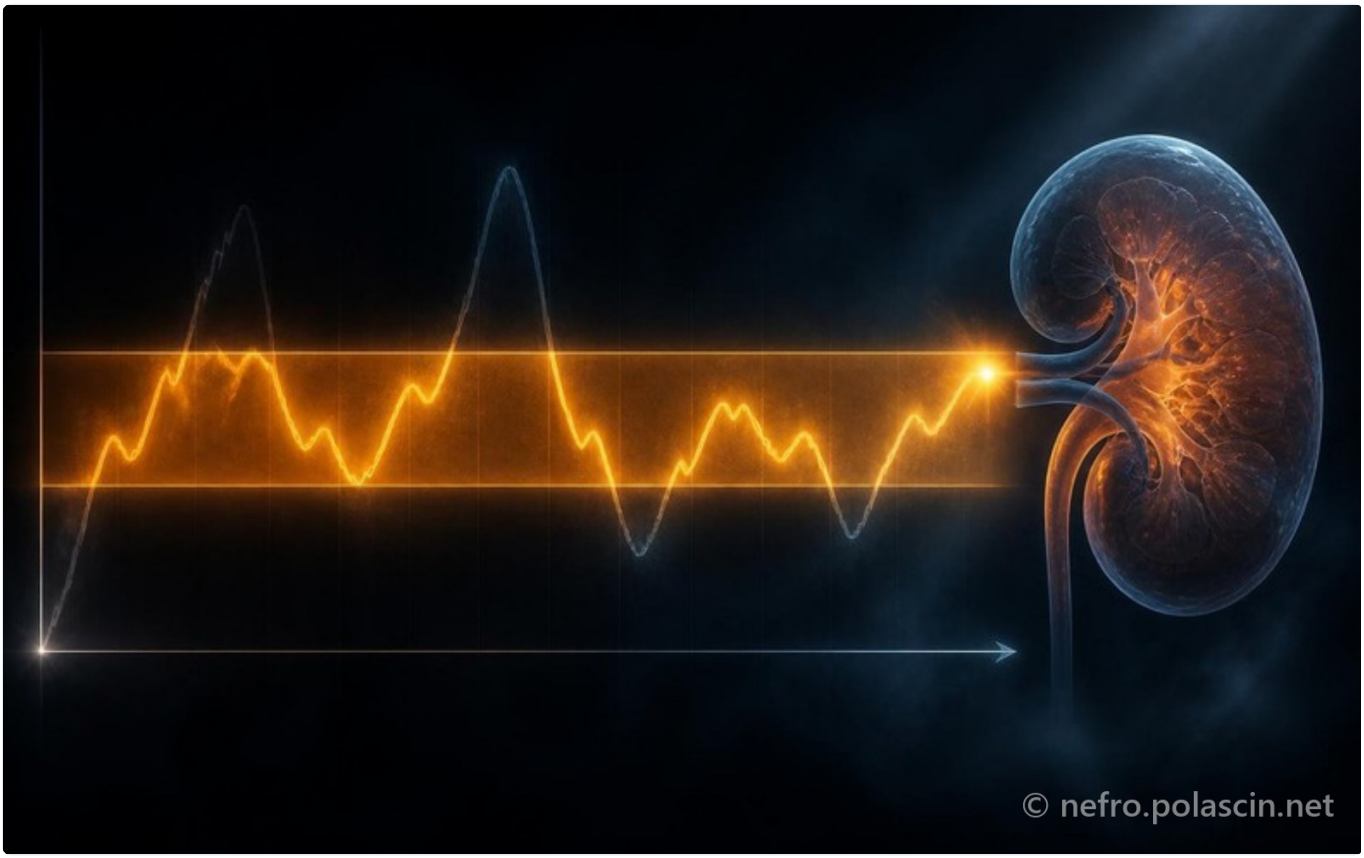
UACR „time in target range" môže pomôcť pri manažmente chronickej choroby obličiek

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 27.05.2026



Poloschematická vizualizácia. Nerozhoduje len posledná hodnota — ale koľko času strávil pacient v cieľovom pásme.

Nový výskum naznačuje, že ukazovateľ, ktorý meria, **koľko času je hodnota UACR (albumín/kreatinín v moči) v cieľovom pásme**, môže nezávisle predpovedať **kardiovaskulárne výsledky** u pacientov s chronickou chorobou obličiek (CKD) a mohol by byť praktickým doplnkom do manažmentu CKD.

Prečo sa rieši „time in target range“

Bežné prístupy hodnotenia dlhodobého UACR podľa článku nezohľadňujú dostatočne **kolísanie hodnôt v čase**. Autori preto navrhujú koncept **TTR (time in target range)** – percento času, za ktoré sa biomarker nachádza vo vopred určenom cieľovom intervale.

Ako príklad Medscape opisuje „trajektóriu“ pacienta z dát elektronických zdravotných záznamov (EHR): ak je UACR **dlhodobo konzistentne vysoký**, ide o nepriaznivé zistenie, zatiaľ čo ak sa hodnota udržiava v pásme považovanom za „v norme“, pacient je v „zelenej zóne“ – v cieľovom rozmedzí.

Dáta z kohorty „All of Us“

Výskumníci analyzovali perspektívnu kohortu **All of Us** (849 000 dospelých v USA). Z nej vybrali **306 645** účastníkov, ktorí mali minimálne **3 merania UACR**.

V analyzovanej populácii bolo priemerne:

- vek **59 rokov**
- **62 %** ženy
- diabetes **8 %**
- hypertenzia **22 %**

- CKD **10 %**
- priemerné UACR **117 mg/g**

Hlavné zistenia: TTR a kardiovaskulárne udalosti

V multivariantnej analýze upravenej na demografiu, anamnézu, lieky a laboratórne parametre:

- **TTR < 30 mg/g** bolo spojené so **zníženým rizikom MACE** (prvá udalosť: infarkt myokardu, mŕtvica alebo smrť) v CKD skupine.
  P-hodnoty boli **0,002** pri tradičnom výpočte TTR a **0,007** pri výpočte podľa **Rosendaalovej lineárnej interpolačnej metódy** (vyvinutej pôvodne pre TTR pri perorálnej antikoagulácii). Podobný trend bol aj v skupine bez CKD (P = **0,001** pre obe metódy).
- Priemerná hodnota UACR sama o sebe v CKD skupine nemusela spoľahlivo zachytiť riziko (hazard ratio blízke 1,00).
- **Vyššia „adherencia“ k cieľu UACR < 30 mg/g** predpovedala **15 % až 18 % zníženie doživotného rizika MACE**.

Čo je podľa článku ďalší krok

Prezident NKF Kirk Campbell v komentári zdôrazňuje, že výsledky zaujímavo ukazujú vzťah albuminúrie a kardiovaskulárnych výsledkov, a že v praxi sa abnormalita v moči často „spája“ s CKD stagingom aj s eGFR. Práve tento prístup by mohol priniesť viac definície do budúcich štúdií.

Článok zároveň naznačuje, že **v krátkom časovom horizonte to pravdepodobne nezmení odporúčania** – skôr ide o tému pre ďalší výskum. V budúcnosti by sa TTR mohol implementovať do EHR pre ľubovoľné laboratórne hodnoty s vopred daným cieľovým rozmedzím.

Zdroj: *Medscape Medical News. Kliknite sem.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=uacr-time-in-target-range-moze-pomoct-pri-manazmente-chronickej-choroby-obliciek · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.